Hybrid DRG 2026 Abrechnung

Berufspolitisches Seminar
52. Deutscher Koloproktologen-Kongress
S. Sauer



CHIRURGICUM
BERLIN

Vortrag: Abrechnung der Hybrid-DRG

AutorIn: Dr. Sandra Sauer, Berlin [6]

Offenlegung finanzieller Interessen:

[1]: BeraterIn (B):	Kommerzielle Vergütung oder Unterstützung der Autorin / des Autors in den letzten drei Jahren in Form von Beraterverträgen (Mitgliedschaft in Gremien, Beiräten, Aufsichtsräten etc.)
[2]: EigentümerIn (E):	Eigentümerinteresse an Arzneimittel/Medizinprodukten (z.B. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz, etc.)
[3]: InvestorIn (I):	Finanzielles Interesse an Firmen, die eine beschriebene Ausrüstung, ein Verfahren oder Produkte liefern (z.B. Aktienbesitz, AnteilseignerIn etc.)
[4]: MitarbeiterIn (M):	Finanzielles Interesse bei der Produktvermarktung (MitarbeiterIn des Produktherstellers)
[5]: Produkt (P):	Finanzielles Interesse bei der Ausrüstung, dem beschriebenen Verfahren und/oder dem beschriebenen Produkt (z.B. Forschungsunterstützungen, Referentenhonorare, Reisekostenunterstützungen, Stipendien etc.)
[6]: Keine (K):	Keine Interessenskonflikte; keine kommerzielle Unterstützung der vorgelegten Arbeit in irgendeiner Form

Hybrid DRG 2026
Leistungskatalog-Proktologie

OPS 20	OPS-Bezeichnung 2026
5-490.0	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision
5-490.1	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision
5-490.x	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige
5-490.y	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: N.n.bez.
5-491.0	Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)
5-491.10	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan
5-491.11	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktär
5-491.12	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktär
5-491.15	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös
5-491.16	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subanodermal
5-491.1x	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Sonstige
5-491.2	Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage
5-491.3	Operative Behandlung von Analfisteln: Verschluss von Analfisteln durch Plug-Technik
5-491.x	Operative Behandlung von Analfisteln: Sonstige
5-491.y	Operative Behandlung von Analfisteln: N.n.bez.
5-492.00	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal
5-492.01	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief
5-492.02	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels
5-492.0x	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Sonstige
5-492.1	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal

Hybrid DRG 2026
Leistungskatalog-Proktologie

OPS 20	OPS-Bezeichnung 2026
5-490.0	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision
5-490.1	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision

Keine Änderungen zu 2025

Weiterhin ausgeschlossen:

- Eingriffe Hämorrhoiden
- Komplexe Analfisteloperationen mit Sphinkterrekonstruktion oder Flap

5-492.02	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels
5-492.0x	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Sonstige
5-492.1	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal

Hybrid DRG 2026
Leistungskatalog-Proktologie-Exkurs
Analfissur

OPS 20	OPS-Bezeichnung 2026
5-490.0	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision
5-490.1	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision
5-490.x	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige
5-490.y	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: N.n.bez.
5-491.0	Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)
5-491.10	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan
5-491.11	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktär
5-491.12	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktär
5-491.15	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös
5-491.16	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subanodermal
5-491.1x	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Sonstige
5-491.2	Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage
5-491.3	Operative Behandlung von Analfisteln: Verschluss von Analfisteln durch Plug-Technik
5-491.x	Operative Behandlung von Analfisteln: Sonstige
5-491.y	Operative Behandlung von Analfisteln: N.n.bez.
5-492.00	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal
5-492.01	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief
5-492.02	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels
5-492.0x	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Sonstige
5-492.1	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal

Hybrid DRG 2026 - Exkurs Analfissur

5-49	**Operationen am Anus**
5-492	**Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals**
	Inkl.: Blutstillung
5-492.0	**Exzision**
	Info: Eine tiefe Exzision reicht mindestens bis zur Muskulatur
5-492.00	Lokal
5-492.01	Tief
	Inkl.: Exzision einer Analfissur
5-492.02	Tief, mit Teilresektion des Muskels
	Inkl.: Exzision eines Analtumors

OPS 2026-Codesuche

Hybrid DRG 2026
Leistungskatalog-Proktologie

OPS 2026	OPS-Bezeichnung 2026
5-891	Inzision eines Sinus pilonidalis
5-897.0	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision
5-897.10	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Mittelliniennaht
5-897.11	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Transpositionsplastik
5-897.12	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Rotations-Plastik
5-897.1x	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Sonstige
5-897.x	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Sonstige
5-897.y	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: N.n.bez.

Hybrid DRG 2026
Leistungskatalog-Proktologie

OPS 2026	OPS-Bezeichnung 2026
5-891	Inzision eines Sinus pilonidalis
5-897.0	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision
5-897.10	
5-897.11	
5-897.12	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Rotations-Plastik
5-897.1x	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Sonstige
5-897.x	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Sonstige
5-897.y	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: N.n.bez.

Keine Änderungen zu 2025

Hybrid DRG 2026
Fallpauschalen-Proktologie

Leistungsbereich	Hybrid-DRG	Fallpauschale der Hybrid-DRG ohne postoperative Nachbehandlung im Krankenhaus (Spalte A) in Euro	Fallpauschale der Hybrid-DRG zuzüglich postoperativer Nachbehandlung im Krankenhaus (Spalte B) in Euro
Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden	G26M	1.426,87	1.456,87
Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden	G26N	1.016,05	1.046,05
Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal	J09M	1.137,07	1.167,07

Vergütung 2025
G26M 961,98
G26N 929,36
J09**N** 1199,83

Hybrid DRG


ICD-10-GM 2026
Systematisches
Verzeichnis
OPS 2026
Systematisches
Verzeichnis
KU
SONDERHEFT
DEUTSCHE
KODIERRICHTLINIEN 2026
Mit ND-Kommentar
InEK
German
Diagnosis
Related
Groups

Hybrid DRG-Vergütungsvereinbarung

Eine Hybrid DRG wird generiert:

- Sofern sich aus dem Definitionshandbuch ,,aG-DRG German Diagnosis Related Groups" des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus eine Zuordnung der jeweiligen Leistung zu der jeweiligen Hybrid-DRG ergibt
- Es gelten die deutschen Kodierrichtlinien

Hybrid DRG 2026

Grundsätzlich nicht betroffen von Hybrid DRG

- Patienten mit Verweildauer von **über** 2 Tagen
- Patienten mit einem PCCL 3
- Aufwendige Diagnosen wie **bestimmte** bösartige Neubildungen
- **Kinder**
- **Menschen mit Behinderung**

Hybrid DRG 2026 - Analkarzinom

C21.- Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals

C21.0 Anus, nicht näher bezeichnet
Exkl.: Anus: Haut (C43.50) (C44.50)
Anus: Rand (-Gebiet) (C43.50) (C44.50)
Perianalhaut (C43.50) (C44.50)

C21.1 Analkanal
Inkl.: Sphincter ani

C21.2 Kloakenregion

C21.8 Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend
Info: [Siehe Hinweis 5 am Anfang dieses Kapitels]
Inkl.: Anorektaler Übergang
Anorektum
Bösartige Neubildung des Rektums, des Anus und des Analkanals, deren Ursprungsort nicht unter den Kategorien C20-C21.2 klassifiziert werden kann

+

5-49 Operationen am Anus

5-492 Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals
Inkl.: Blutstillung

5-492.0 Exzision
Info: Eine tiefe Exzision reicht mindestens bis zur Muskulatur

5-492.00 Lokal
5-492.01 Tief

=

Hybrid DRG G26M

ICD 2026-OPS 2026-Codesuche

Hybrid DRG 2026 - Analrandkarzinom

C44.- Sonstige bösartige Neubildungen der Haut

C44.5- Haut des Rumpfes

C44.50 Perianalhaut

Inkl.: Anus: Haut
Anus: Rand (-Gebiet)

Exkl.: Anus o.n.A. (C21.0)

+

5-49 Operationen am Anus

5-490 Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion

Inkl.: Inzision oder Exzision bei perianaler Thrombose

5-490.1 Exzision

≠ **Hybrid DRG**

ICD 2026-OPS 2026-Codesuche

Hybrid DRG 2026 - Analrandkarzinom

C44.- Sonstige bösartige Neubildungen der Haut

C44.5- Haut des Rumpfes

C44.50 Perianalhaut

Inkl.: Anus: Haut
Anus: Rand (-Gebiet)

Exkl.: Anus o.n.A. (C21.0)

+

5-49 Operationen am Anus

5-490 Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion

Inkl.: Inzision oder Exzision bei perianaler Thrombose

5-490.1 Exzision

=

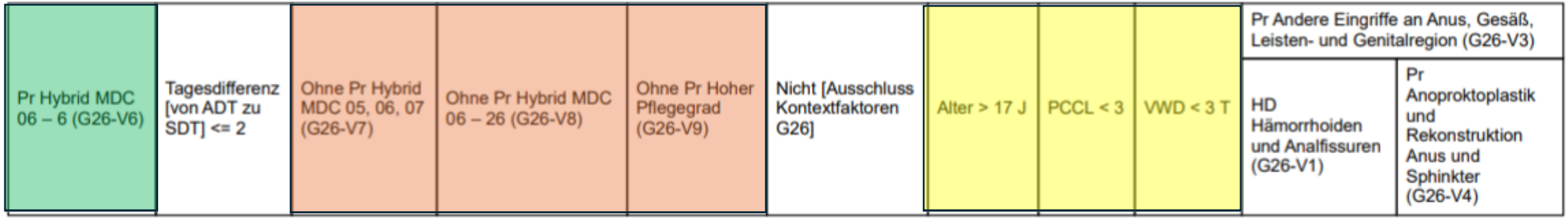
DRG J09B

Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter > 15 Jahre

ICD 2026-OPS 2026-Codesuche

Hybrid DRG – „Abrechnungskette“

DRG G26N **Hybrid-DRG der DRG G26B**



H-DRG-OPS

Ausschluss OPS-Codes

Ausschluss ICD-Codes

Ausschluss Alter, Verweildauer, Grunderkrankung

Hybrid DRG 2026 - Analkarzinom

Diagnosen:	C44.50	C21.0								
(ICD)										

Prozeduren:	5-490.1	am 16.03.2026	5-492.0	am 16.03.2026					
(OPS)									
(OPS)									
(OPS)									
(OPS)									

Basisfallwert*: 4561,37 € Pflegeentgeltwert*: 250 €

G-DRG 2026 | Gruppieren | Neuer Fall

Gruppierungsergebnis (G-DRG 2026)		
MDC	09	Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma
DRG	J09B	Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter > 15 Jahre
PCCL	2	Status: normales Grouping (GetDRG-Grouper 2026) (GetDRG V25.2.2.0)

DRG research group online grouper

Hybrid-DRG - „Abrechnungskette“

Hybrid MDC 06 – 6 (G26-V6)

5-490.0	Inzision von Gewebe der Perianalregion
5-490.1	Exzision von Gewebe der Perianalregion
5-490.x	Sonst Inzis u Exzis Gew Perianalreg
5-490.y	Inzis u Exzis Gew Perianalreg, nnbez
5-491.0	Inzision (Spaltung) von Analfisteln
5-491.10	Exzision von Analfisteln, subkutan
5-491.11	Exzision von Analfisteln, intersphinktär
5-491.12	Exzision von Analfisteln, transsphinktär
5-491.15	Exzision von Analfisteln, submukös
5-491.16	Exzision von Analfisteln, subanodermal
5-491.1x	Sonstige Exzision von Analfisteln
5-491.2	Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage
5-491.3	Operative Behandl v Analfist: Verschl v Analfist d Plug-Technik
5-491.x	Operative Behandlung von Analfisteln: Sonstige
5-491.y	Operative Behandlung von Analfisteln: Nnbez
5-492.00	Lok Exz erkr Gew Analkanal
5-492.01	Tief Exz erkr Gew Analkanal
5-492.02	Tief Exz erkr Gew Analkanal m TeilRes Muskel
5-492.0x	Sonst Exz u Destr erkr Gew Analkanal
5-492.1	Lok Destr erkr Gew Analkanal

H-DRG-OPS

DRG G26N

Hybrid-DRG der DRG G26B

Pr Hybrid MDC 06 – 6 (G26-V6)	Tagesdifferenz [von ADT zu SDT] <= 2	Ohne Pr Hybrid MDC 05, 06, 07 (G26-V7)	Ohne Pr Hybrid MDC 06 – 26 (G26-V8)	Ohne Pr Hoher Pflegegrad (G26-V9)

Auschluss OPS-Codes

Hybrid MDC 06 – 26 (G26-V8)

5-491.4	Exz inter-/transsphinkt Analfist m Verschl Schleimhautlappen
5-491.5	Exz Analfistel m Verschl durch Muskel-Schleimhaut-Lappen

Einhaltung der Kodierrichtlinien

ALLGEMEINE KODIERRICHTLINIEN FÜR PROZEDUREN

Diese Kodierrichtlinien beziehen sich auf den **amtlichen Operationen- und Prozedurenschlüssel OPS Version 2026**.

P001f Allgemeine Kodierrichtlinien für Prozeduren

Alle signifikanten Prozeduren, die vom Zeitpunkt der Aufnahme bis zum Zeitpunkt der Entlassung vorgenommen wurden und im OPS abbildbar sind, sind zu kodieren. Dieses schließt diagnostische, therapeutische und pflegerische Prozeduren ein.

Die Definition einer signifikanten Prozedur ist, dass sie entweder

- chirurgischer Natur ist
- ein Eingriffsrisiko birgt
- ein Anästhesierisiko birgt
- Spezialeinrichtungen oder Geräte oder spezielle Ausbildung erfordert.

Es ist besonders wichtig, dass alle signifikanten und kodierbaren Prozeduren, einschließlich traditioneller „nicht-chirurgischer" Prozeduren verschlüsselt werden.

Es gibt keine Kodierrichtlinie, die die Reihenfolge der Prozeduren regelt. Jedoch sollten die aufwändigeren Prozeduren zuerst angegeben werden, da die Anzahl der zur Verfügung stehenden Schlüsselnummer-Felder begrenzt ist.

Die Reihenfolge der Prozeduren hat keinen Einfluss auf die DRG-Gruppierung.

Alle signifikanten Prozeduren kodieren

- Die Reihenfolge der Kodierung ist
  egal
- Sowohl ICD als auch OPS können
  in eine höhere Hybrid-DRG triggern
  - Dies ist für jede Hybrid DRG zu prüfen

Einhaltung der Kodierrichtlinien

Prozedurenkomponenten

Normalerweise ist eine Prozedur vollständig mit all ihren Komponenten, wie z.B. Vorbereitung, Lagerung, Anästhesie, Zugang, Naht, usw., in einem Kode abgebildet (siehe Beispiel 1 und 2). Abweichungen davon sind in den Hinweisen beschrieben. Bei den Operationen am Nervensystem zum Beispiel ist gewöhnlich der Zugang zusätzlich zu kodieren.

Deshalb werden diese individuellen Komponenten einer bereits kodierten Prozedur nicht noch einmal gesondert verschlüsselt.

Dt. Kodierrichtlinien 2026

→ Diskussion: Exzision der Mariske im Rahmen der Hämorrhoidektomie

Hybrid DRG - Exkurs Condylome

Spezielle Kodierrichtlinie, Deutsche Kodierrichtlinien 2026

1403d Anogenitale Warzen

Aufnahmen zur Behandlung von **anogenitalen Warzen** werden mit einer Hauptdiagnose aus der unten angeführten Liste kodiert:

Perianal	K62.8	*Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums*
Cervix uteri betreffend	N88.8	*Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri*
Vaginal	N89.8	*Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vagina*
Vulva betreffend	N90.8	*Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums*
Penis betreffend	N48.8	*Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Penis*

Der Kode

A63.0 *Anogenitale (venerische) Warzen*

ist als Nebendiagnose anzugeben.

Hybrid DRG 2026 – Sachkosten / Pathologie

Zusammengefasste Regelungen zu § 115f SGB V (HybridDRG) für das Jahr 2026 gemäß den Beschlüssen des ergänzten erweiterten Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 5a SGB V

5. Vergütung für Leistungen

….

(5) Die folgenden Leistungen **sind nicht zusätzlich** zu einer Fallpauschale und ggf. den Zusatzentgelten
abrechenbar:

….

5. Sachkosten und Arzneimittel mit Ausnahme von Sprechstundenbedarf,

6. histopathologische und zytologische Beurteilung von intraoperativ entnommenen Materials gemäß
Indikation und diagnostischer oder therapeutischer Fragestellung

Hybrid DRG 2026 – Pathologie

Abrechnung von Leistungen der Pathologie über das „normale Mass“ hinaus

Stellungnahme der KBV vom 09/25 per Mail:

…..

„Der § 5 Absatz 5 Punkt 6 der Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung gibt keine klare Abgrenzung der enthaltenen histopathologischen Leistungen gemäß EBM-Logik vor.

Bestandteil der Hybrid-DRG ist die erste Untersuchung zur histopathologischen und zytologischen Beurteilung von intraoperativ entnommenem Material. Weiterführende Untersuchungen der Tumordiagnostik, u. a. zur Therapieentscheidung unter Beteiligung weiterer nichtoperativer Fachgruppen, wären nach dem EBM berechnungsfähig und nicht Bestandteil der H-DRG.“

Wir möchten als KBV darauf hinweisen, dass diese Sprachregelung als nicht verbindlich gilt und wir keine Gewähr für eine entsprechende Umsetzung geben können.

Hybrid DRG 2026 – Zusammenfassung

- In Hinblick auf die Proktologie kaum Änderungen zu 2025
- Der Teufel liegt im Detail! – Bsp. Analkarzinom
- Um eine Herausnahme proktologischer Leistungen aus den Hybrid DRG zu vermeiden, sollte die Einhaltung der Kodierrichtlinien,… erfolgen
- Die Aufnahme der Hämorrhoidektomie in den Hybrid DRG Leistungskatalog wäre wünschenswert

Hybrid DRG 2026 – Hinweis

- Die in dieser Präsentation erfolgten Darstellungen / Hinweise sind alle ohne Gewähr!!

Hybrid DRG 2026 Abrechnung

Berufspolitisches Seminar
52. Deutscher Koloproktologen-Kongress
S. Sauer

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!!!

BERUFSVERBAND COLOPROKTOLOGIE DEUTSCHLAND E.V. · GEGR. 1979 ·

CHIRURGICUM BERLIN